

j'ai un bouton embryonnaire et j'ai une cavité, le blastocène. Au moment où je rentre dans la muqueuse, il y a une deuxième cavité qui apparaît. Et là, j'ai deux types de cellules qui s'échangent. Un qui regarde la cavité ancienne, et à ce moment-là, on commence à parler, pour Blech-Schmidt simplement, d'un endocyste, ou dans l'embryologie classique, d'un épiblaste et d'un hypoblaste. Au moment où maintenant je vais avoir la troisième chambre qui va apparaître, il va y avoir un nouveau système. C'est donc une vitesse de croissance différentielle entre l'extérieur et l'intérieur. À l'intérieur, je grandis un peu moins vite parce que la porthropie arrive moins vite, c'est tout. Si moi, je te donne à manger beaucoup plus vite, et que là-bas, tu te dis, tu mangeras moins vite que lui. Au niveau de mon tissu, il y a un phénomène important qui va apparaître, et là, je vais induire des négatives. Ce sont des nouvelles informations, c'est ce qu'on appelle des champs métaboliques de précocité, de perméation, de parméation et d'infusion dans l'apport trophique de l'information. Autre mot, une organisation de comment l'information trophique, donc de comment cette nourriture primitive se distribue dans les tissus pour les transformer. Ok ? Pour ça, Blech-Schmidt a compris... Comment ça se passait ? Il a introduit des nouvelles notions qu'on retrouve que dans l'embryologie biodynamique, que l'information se distribue à la fois de façon, ce qu'on appelle dans un champ, de parméation, de perméation ou d'infusion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je prends une couche de cellules. L'information trophique arrive maintenant d'une façon beaucoup plus spécifique, d'une façon polarisée. Si vous avez vu le petit dessin, vous avez vu qu'il y a une zone qui relie à l'extérieur. Au départ, c'était partout. Et dans l'apparition de ma cavité viteline, de ma cavité amniotique et de mon cellulome externe, s'organise ce qu'on appelle une pellicule embryonnaire. C'est-à-dire que l'information trophique ne vient plus partout, mais elle vient d'une façon orientée. Maintenant, ça

s'organise. Je ne sais pas arriver tout le monde, j'arrive d'un côté. Et ce côté, ça s'appelle le pédicule embryonnaire. Si je regarde un groupe de cellules qui vont recevoir à manger, On constate que ça va arriver de trois façons différentes, depuis le pédicule embryonnaire. Un, l'information peut passer le long de la membrane, le long des membranes. Quand ça passe le long, de façon parallèle, linéaire, ça porte le champ de perméation. Ça peut aussi passer entre les cellules. Donc ça arrive comme ça, ok ? Mais là, l'information, cette fois-ci, elle devient perméation entre mes cellules. Troisième étape, la cellule est là qui est en tout. Maintenant, c'est elle qui veut manger. Et ça, ça correspond à un champ métabolique d'infusion. Vous avez suivi ça ? Oui, c'est bon. Ça va introduire un mouvement très important qui fait qu'on va passer complètement du zygote, maintenant, à un fémur. C'est un fœtus primitif. Au départ, on peut dire que l'information trophique est un peu générale, comme ça. Il n'y a pas encore de lien, vraiment. Mais au moment où j'ai ce passage de mon blastocèle en une cavité viteline et un cellulome externe, il y a une autre chose qui se passe. On voit ici que tout d'un coup, j'ai une concentration ici. Il n'y a plus qu'un lien avec tout ce petit mass et la partie extérieure. Pour former plus tard le placenta, tout bas. Et ça, ça s'appelle le pellicule embryonnaire, ou on pourrait dire le cordon ombilical primitif. C'est un lieu trophique. Et là, il y a cette organisation de mouvements métaboliques qui vont arriver. C'est-à-dire que si je prends maintenant un embryon à ce stade-ci, je vais le dessiner comme ceci. J'ai donc une couche de cellules qu'on va appeler la cavité. La cavité amniotique. J'ai une couche de cellules en dessous qui vont s'appeler la cavité viteline. L'ensemble, ici au-dessus, je peux dire que j'ai une couche de cellules qui vont former épiblaste. En dessous, hypoblaste. Ici, le tout est relié à un pellicule embryonnaire. Et l'ensemble est dans une cavité. L'ensemble est dans une cavité qu'on appelle le cellulome externe. Ok ? À ce moment-là, on voit qu'il y

a une source trophique qui est organisée de l'extérieur vers l'intérieur, mais qui est polarisée. Et c'est là où on constate un mouvement de par la polarité. La partie supérieure était déjà ici à une plus grande activité métabolique, de par sa position avant. L'activité métabolique se fait comme ceci. L'information, elle se fait là. Plus préférentiellement d'abord dans un champ de perméation. En même temps, j'ai un champ métabolique. En même temps, j'ai un champ métabolique. Central de perméation et d'infusion et de perméation. Mais ça organise ce mouvement métabolique à faire un mouvement de l'embryon comme ceci. Que ma cavité viteline se déplace vers l'avant. et ma cavité amniotique se déplace vers l'arrière, comme ceci. Et ce mouvement va introduire au sein de mon disque germinale une forme en S. C'est-à-dire que par ce mouvement, le tissu qui au départ était plat, ça va former un tissu qui va former un mouvement comme ceci. Par l'activité métabolique qui amène la cavité viteline vers l'avant et ma cavité viteline vers l'arrière, mais dans la croissance. Cavité amniotique en avant, cavité viteline en arrière. Tu vois le disque plat. Cavité amniotique, cavité viteline, pédicule embryonnaire, phélomexter. Quelle est l'erreur entre ces deux dessins ? Ceci doit être beaucoup plus grand que là. Là on voit comme si c'était la même. C'est très important, vraiment, l'erreur qu'ils ont faite dans ce dessin. Je devrais presque découper, refaire plus petit ce dessin, et mettre beaucoup plus grand pour avoir une vision plus juste. Parce que c'est dans ce passage-là, entre mon phélome externe qui se crée ici, et ma cavité viteline qui devient viteline à la place du cellulome, du blastocèle, que j'ai mon pellicule qui se dessine. Et dans ce pellicule, j'ai un mouvement de perméation, perméation, infusion capable qui arrive. Ça se développe plus au-dessus ici, ça amène un mouvement vers l'avant de ma cavité amniotique. Légèrement moins en dessous. Ça crée une bascule, et ce mouvement de bascule crée ceci. Une forme de S au sein de mon épiblaste et de mon endoblaste.